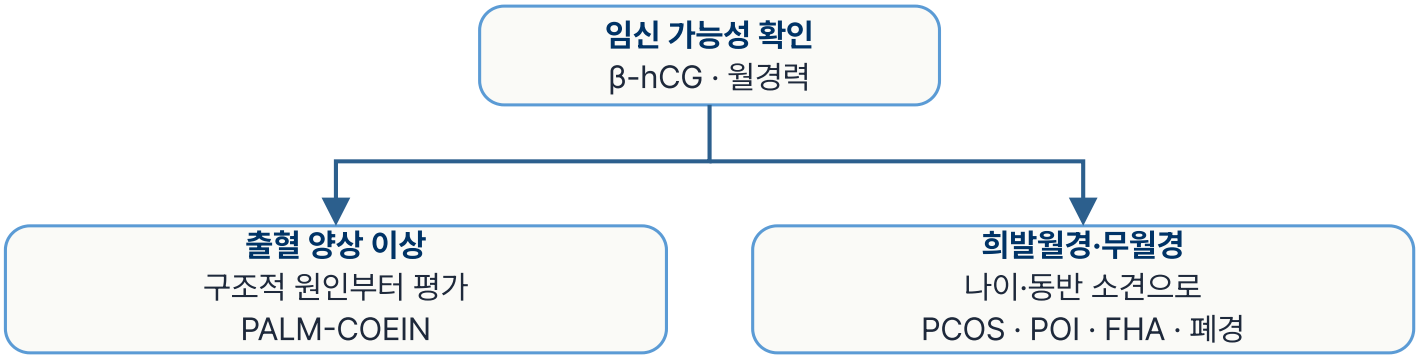
# 불규칙 월경·무월경 초진에서 의뢰까지

월경력은 전신 건강의 단서 · 가임기에서는 임신 배제가 먼저

## 먼저 두 경로로 나눕니다




## 병력과 진찰을 묶어 기록

- ☐ 초경 나이·LMP·최근 **3~6개월**의 주기·기간·출혈량, 산과력·피임법·임신 가능성
- ☐ 체중 변화·만성질환·약물(항응고제·항정신병약 등), 암·조기폐경·출혈성 질환 가족력
- ☐ 활력징후·BMI·갑상선, 유즙분비, 다모증·여드름·남성형 탈모, 복부 종괴·압통

**이사라 연자 Q&A · 무월경 상담** — **3개월 이상** 무월경이면 LH·FSH·E2·PRL·TSH 기본 평가와 산부인과 진료를 강조했습니다.

## 기본검사와 산부인과 연결

| 내과 초진 | 산부인과 평가로 연결 |
|---|---|
| β-hCG · CBC · TSH | 질경검사: 자궁경부 병변·용종·출혈 부위<br>양손 골반진찰: 자궁·부속기 |
| 소견에 따라 PRL · FSH/LH/E2<br>Testosterone · DHEA-S · 17-OHP | 경질초음파(TVUS) 1차 영상<br>성경험 없으면 경항문초음파 |
| 초경부터 심한 과다월경: Ferritin · 응고검사 · von Willebrand 인자 선별 고려 | 자궁강 병변: SIS → 자궁경·생검<br>복잡한 근종·선근증·기형: MRI |

## 의뢰를 앞당길 출혈

**폐경 후 출혈 · 성교 후 출혈 · 심한 빈혈 증상**

폐경 후 출혈은 **소량·일시적이어도** 자궁내막암을 배제합니다. 어지러움·실신을 동반한 심한 빈혈 증상, 성교 후 출혈은 진찰·검사를 연결합니다.

**광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine**
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · 031-893-4560

# 출혈 양상과 연령별 기준

초진 상세 ① · 구조적 병변과 청소년·성인 PCOS를 구분

## 월경 지표는 이렇게 읽습니다

| 도입부 월경 지표 | 생애주기표와 청소년기 |
|---|---|
| 빈도 **21~35일** · 규칙성 변이 **7~9일**<br>기간 **2~7일 이내** · 출혈량 **5~80 mL** | 생애주기표 성인(18~45세): **24~38일**<br>초경 후 1~3년: **21~45일** |
| 양은 주관적 평가: 중형 패드를 **2~3시간마다** 교체하거나 매번 밤에 오버나이트 사용 여부 문진 | 초경 후 3년 이후: **21~35일**<br>연 **8회 미만** 월경은 희발월경<br>유방 발달 후 **3년 이내** 초경이 없으면 원발성 무월경 평가 |

청소년은 초경 후 **1년 이내라도** 월경 간격이 **90일 이상**이면 비정상으로 평가합니다.

## AUB: PALM-COEIN

| 구조적 PALM | 비구조적 COEIN |
|---|---|
| P 용종 · A 선근증<br>L 근종 · M 악성·증식증 | C 응고장애 · O 배란장애 · E 자궁내막<br>I 의인성·약물성 · N 미분류 |

### 암을 놓치지 않는 의뢰

폐경 후 출혈에서 내막 두께가 **4~5 mm 기준을 초과**하면 생검을 고려합니다. 가임기 **45세 이상** 또는 위험인자 동반 불규칙 출혈도 생검 고려. 육안적 자궁경부 병변은 **Pap 결과와 무관하게** 조직생검 의뢰. 용종 제거 후에도 조직학적 확인.

## 청소년 PCOS와 성인 PCOS

| 청소년 | 성인 |
|---|---|
| 월경 불규칙/배란장애와 고안드로겐혈증 **모두** 필요. 초음파 PCOM·AMH는 진단기준에서 제외 | 배란장애 · 고안드로겐혈증 · PCOM 중 **2/3** + 다른 원인 배제. 성인은 AMH 상승으로 PCOM 대체 가능 |
| 한 기준만 있으면 **at risk**로 추적하고 초경 후 **8년** 시점 재평가 | 갑상선·PRL·비전형 선천성부신과형성·FHA·POI·임신 감별. 쿠싱 표현형이면 24시간 소변 유리코르티솔 등 |

## 성인 PCOS의 내과 연결

### 대사 평가와 생식 목표

연자는 비만 여부와 관계없이 PCOS 의심 환자의 **75g OGTT** 평가를 설명했습니다. 생활습관·체중 관리와 함께 피임·임신 계획을 확인합니다. 강의 증례에서는 피임과 고안드로겐 증상 조절 목적으로 복합경구피임제를 사용했습니다.

# 무월경: POI · FHA · 폐경

초진 상세 ② · 임신·갑상선·프로락틴과 기질적 원인을 감별

## 40세 미만 + 폐경 유사 증상

### 강의의 조기난소부전(POI) 평가

**40세 미만** + 희발월경/무월경 **4개월 이상** → FSH **>25 IU/L** → **4주 이상** 간격으로 FSH 상승을 2회 확인하는 경로를 제시했습니다. E2 **<50 pg/mL**는 보조 소견이며 단독 진단기준이 아닙니다. AMH는 1차 검사로 권고하지 않았습니다.

## POI 이후의 의뢰 내용

| 원인 평가 | 장기 건강·생식 상담 |
|---|---|
| 수술·항암·방사선력, 핵형·FMR1 premutation·21-OH 항체, TSH<br>TPO 항체는 POI 진단검사로 권장하지 않음 | 자연 폐경 연령(약 **50세**)까지 호르몬 치료, 골밀도·심혈관 위험 관리, 생식 상담 |
| TSH: 증상 시 및 **5년 간격**<br>Turner에서 Y 염색체 평가·수술은 전문과 연계 | 간헐적 배란과 자연임신 가능성은 남아 있음. 가족력이 있으면 가족 상담도 연결 |

## 저체중·과운동·스트레스라면 FHA

### 기능성 시상하부성 무월경은 배제 진단

정상 체중이라도 고강도 운동·에너지 부족이면 고려합니다. 임신·PRL·TSH·PCOS·POI·기질적 원인 배제 후 낮거나 정상 하한 LH/FSH와 저E2를 평가합니다. **두통·시야장애·다뇨·다음**이 동반되면 뇌하수체 MRI. 영양·심리·운동 조절을 연결하고, **6개월 이상** 무월경이면 DXA 평가. 골밀도 저하 시 호르몬 치료를 설명했습니다. FHA에서는 경구복합피임약을 골밀도 개선만을 위한 단독 치료로 권하지 않았습니다.

## 폐경을 구분하고 다음 진료를 남깁니다

| 연령·상황 | 강의의 진단 접근 |
|---|---|
| **45세 이상** + 다른 원인 없는 **12개월** 연속 무월경 | 전형적 증상이면 호르몬 검사 없이 임상 진단 |
| **40~45세** 폐경 증상·주기 변화 / **40세 미만** | 호르몬 평가 고려 / POI 평가로 전환 |
| 호르몬 피임제·호르몬 IUD 사용 중 | 출혈 패턴만으로 폐경 판단하지 않음. 이행기 FSH 단회로 확정하지 않으며 피임 상담 병행 |

**광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine**
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · 031-893-4560


자료 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/gynecology/irregular-menses-initial-card/